Nová tabletka znižuje ťažko kontrolovateľný tlak a môže chrániť obličky

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 19.05.2026



Ilustračná scéna. Pri tlaku, ktorý nereaguje na bežnú liečbu, môže nová molekula posunúť hranicu dosiahnuteľného.

Pacienti s chronickou chorobou obličiek a nekontrolovanou hypertenziou patria medzi najrizikovejšie skupiny v klinickej praxi. Vysoký krvný tlak urýchľuje poškodenie obličiek a zhoršovanie funkcie obličiek zároveň ďalej zvyšuje tlak. Vzniká tak bludný kruh, ktorý zvyšuje riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, srdcového zlyhávania aj konečného zlyhania obličiek.

Práve na tento problém sa zamerala štúdia s experimentálnym liekom **baxdrostat**, publikovaná v *Journal of the American Society of Nephrology*. Výsledky naznačujú, že nový liek môže nielen znižovať systolický krvný tlak, ale aj zlepšovať ukazovatele poškodenia obličiek.

Čo je baxdrostat

Baxdrostat je experimentálny liek, ktorý patrí medzi **inhibítory aldosterón-syntázy**. Jeho cieľom je znížiť tvorbu **aldosterónu**, hormónu, ktorý sa podieľa na regulácii soli, vody a krvného tlaku.

Ak je aldosterónu priveľa, telo zadržiava sodík a vodu, tlak stúpa a zároveň sa môžu zhoršovať cievne aj renálne zmeny. Práve preto sa skúma, či blokáda jeho tvorby môže pomôcť pacientom, u ktorých tlak zostáva vysoký napriek štandardnej liečbe.

Kto bol zaradený do štúdie

Do randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej fázy 2 bolo zaradených **195 pacientov** s chronickou chorobou obličiek a nekontrolovanou hypertenziou. Väčšina užívala ACE inhibítor alebo sartan v maximálnej tolerovanej dávke, no tlak zostával vysoký.

Priemerný vstupný systolický tlak bol približne **151 mm Hg**. Priemerné **eGFR** bolo **44 ml/min/1,73 m²** a priemerný pomer albumínu ku kreatinínu v moči bol približne **714 mg/g**, čo svedčí o výraznom renálnom riziku.

Až **80 %** účastníkov malo diabetes 2. typu. Išlo teda o veľmi rizikovú populáciu, v ktorej je potrebná účinnejšia kontrola tlaku aj ochrana obličiek.

Aký bol výsledok

Po 26 týždňoch malo podávanie baxdrostatu lepší efekt než placebo. Systolický krvný tlak klesol v priemere o **8,1 mm Hg viac** než pri placebe.

Ešte zaujímavejší bol vplyv na **albuminúriu**. V skupine s baxdrostatom klesla hladina albumínu v moči o **55 %** oproti placebu. To je dôležité, pretože albuminúria patrí medzi hlavné markery poškodenia obličiek aj kardiovaskulárneho rizika.

Bezpečnosť

Najčastejším nežiaducim účinkom bola **hyperkaliémia**, teda zvýšená hladina draslíka v sére. Objavila sa u **41 %** pacientov liečených baxdrostatom oproti **5 %** v skupine s placebom. Väčšina prípadov bola mierna až stredne závažná.

Počas štúdie neboli hlásené žiadne úmrtia ani nečakané nežiaduce udalosti. Závažné nežiaduce udalosti sa vyskytli u menšej časti pacientov.

Prečo sú tieto dáta dôležité

Výsledky sú dôležité z dvoch dôvodov. Po prvé, ukazujú, že aldosterón môže byť relevantným terapeutickým cieľom u pacientov s CKD a rezistentnou hypertenziou. Po druhé, pokles albuminúrie naznačuje, že účinok nemusí byť iba hemodynamický, ale môže mať aj nefroprotektívny potenciál.

Zatiaľ nejde o dôkaz, že baxdrostat bráni zlyhaniu obličiek. To majú potvrdiť veľké štúdie fázy 3. Už teraz je však zrejmé, že ide o zaujímavý smer vývoja, najmä pre pacientov, u ktorých bežná liečba nestačí.

Čo to znamená pre prax

Pre nefrológiu je to ďalší signál, že budúcnosť liečby chronickej choroby obličiek sa nebude opierať iba o klasickú blokádu RAAS, ale aj o presnejšie cielenie ďalších hormonálnych a zápalových dráh.

Ak sa výsledky potvrdia v ďalších štúdiách, baxdrostat alebo podobné lieky môžu priniesť novú možnosť pre pacientov s CKD, vysokým tlakom a vysokým kardiovaskulárnym rizikom.

Zdroj: SciTechDaily, „New Pill Lowers Stubborn Blood Pressure and Protects the Kidneys“
Odkaz: https://scitechdaily.com/new-pill-lowers-stubborn-blood-pressure-and-protects-the-kidneys/

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nova-tabletka-znizuje-tazko-kontrolovatelny-tlak-a-moze-chranit-oblicky · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.